BONUS 1

Prije nego što nazovete specijalista: priprema u 25 situacija

Za 25 situacija na dežurstvu pogledajte, jednu po jednu, koje snimke moraju biti otvorene, koji prozori spremni i koji podaci pred Vama prije nego što podignete slušalicu te kojom rečenicom započeti razgovor.

Sadržaj

Kako dobro obaviti poziv: SBAR

Opći kontrolni popis prije svakog poziva

Poglavlje 1 · Neurološka stanja (1–6)

Poglavlje 2 · Stanja prsnog koša i krvnih žila (7–10)

Poglavlje 3 · Stanja abdomena i zdjelice (11–17)

Poglavlje 4 · Trauma i stanja kralježnice (18–21)

Poglavlje 5 · Situacije vezane uz sigurnost, protokol i opis (22–25)

Nakon poziva

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako dobro obaviti poziv: SBAR

Strukturirani razgovor kako bi Vaš mentor razumio situaciju već u prvih nekoliko rečenica.

> *Prvo pitanje specijalista kojeg nazovete u ponoć uvijek je isto: «Što si vidio i što trebaš od mene?» SBAR odgovara na ta dva pitanja prije nego što ih on uopće postavi.*

SLOVO	ZNAČENJE	ŠTO REĆI
S	Situacija (Situation)	Tko ste, koji bolesnik, koja pretraga, zašto zovete: jedna rečenica.
B	Anamneza i kontekst (Background)	Kliničko pitanje, relevantna anamneza, laboratorij, prethodna pretraga.
A	Procjena (Assessment)	Što vidite, gdje i što mislite.
R	Preporuka / zahtjev (Recommendation)	Što trebate od mentora: da pogleda snimke, odluku o protokolu, odobrenje opisa, da dođe.

Obrazac uvodne rečenice

«Doktore, ovdje specijalizant na dežurstvu [Vaše ime]. Očitavam [pretraga] bolesnika [dob/spol] s odjela [odjel]. Vidim izgled koji upućuje na [nalaz] i zovem zbog [Vaš zahtjev].»

Ne odgađajte poziv

Popisi za pripremu služe tome da poboljšaju poziv, a ne da ga odgode. Ako je bolesnik nestabilan ili vidite nalaz koji ugrožava život, najprije nazovite; ono što nedostaje dopunit ćete tijekom razgovora.

SVAKI PUT

Opći kontrolni popis prije svakog poziva

Osnovna priprema koja vrijedi za svih 25 situacija.

Prije nego što podignete slušalicu

- [ ] Pomoću dva identifikatora provjerio/la sam identitet bolesnika i to da pretraga pripada pravom bolesniku.
- [ ] Pred sobom imam naziv, datum, vrijeme i protokol pretrage (s kontrastom / bez kontrasta, faze).
- [ ] Relevantne snimke otvorene su u PACS-u; označen je presjek na kojem se nalaz najbolje vidi.
- [ ] Potreban prozor ili sekvencija su spremni.
- [ ] Provjerio/la sam postoji li prethodna pretraga; ako postoji, otvorena je usporedno.
- [ ] Pred sobom imam kliničko pitanje i anamnezu s uputnice.
- [ ] Pogledao/la sam relevantne laboratorijske nalaze.
- [ ] Znam trenutačno kliničko stanje bolesnika (stabilan / nestabilan, gdje se nalazi).
- [ ] Jednom rečenicom mogu reći što trebam od mentora.
- [ ] Papir za bilješke ili nacrt opisa otvoren.

POGLAVLJE 1

Neurološka stanja

Situacije 1–6 · Krvarenje, moždani udar, intrakranijalni tlak i kompresija kralježnične moždine.

Situacija 01 NEURO

Sumnja na subarahnoidalno krvarenje

NEKA BUDE SPREMNO

- Nativni CT mozga; moždani prozor i uski prozor (za moždani udar).
- Označene bazalne cisterne, Silvijeve fisure i okcipitalni rogovi.
- Veličina ventrikula i temporalni rogovi: hidrocefalus da/ne.
- Vrijeme početka simptoma, stanje svijesti, uzimanje antikoagulansa.
- Prethodna pretraga mozga, ako postoji.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na nativnom CT-u mozga bolesnika koji je iz hitne službe došao s naglo nastalom jakom glavoboljom vidim hiperdenzitet u bazalnim cisternama koji odgovara subarahnoidalnom krvarenju. Hidrocefalus [postoji/ne postoji]. Molim Vas da pogledate snimke i da razgovaramo o odluci o CT angiografiji.»*

Situacija 02 NEURO

Kod za moždani udar

NEKA BUDE SPREMNO

- Nativni CT i uski prozor za moždani udar; procjena krvarenja završena.
- Označena hiperdenzna arterija i područja rane ishemije.
- Ako je učinjena CTA ili perfuzija, otvorena je, a sljedeće serije su spremne.
- Vrijeme početka simptoma ili vrijeme kad je bolesnik posljednji put viđen zdrav.
- Neurološka slika (koja strana, koji deficit), uzimanje antikoagulansa.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, bolesnik je kod za moždani udar; početak simptoma [vrijeme]. Na nativnom CT-u nisam vidio/la krvarenje. Postoji hiperdenzna arterija u [strana] MCA i sumnja na ranu ishemiju [regija]. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti CTA.»*

Situacija 03 NEURO

Intrakranijalno krvarenje u bolesnika na antikoagulantnoj terapiji

NEKA BUDE SPREMNO

- Moždani, subduralni (široki) i koštani prozor.
- Mjesto hematoma, trodimenzionalne mjere, najdeblje mjesto.
- Mjerenje pomaka središnje linije, bazalne cisterne, prodor u ventrikule.
- Vrsta antikoagulansa ili antiagregacijskog lijeka, koagulacijski testovi, anamneza traume.
- Usporedba s prethodnom pretragom, ako postoji.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u mozga bolesnika u dobi od [dob] godina koji uzima antikoagulanse vidim akutno krvarenje [mjesto]; pomak središnje linije [postoji/ne postoji]. Prijavio/la sam kliničaru. Htio/htjela bih zajedno s Vama pregledati mjerenja i znakove hernijacije.»*

Situacija 04 NEURO

Sumnjam na izodenzni subduralni hematom, ali nisam siguran/sigurna

NEKA BUDE SPREMNO

- Konveksiteti u širokom prozoru; izgled brazda obiju strana jedan uz drugi.
- Neizravni nalazi: izbrisane brazde, kompresija ventrikula, potiskivanje granice sive i bijele tvari prema unutra.
- Koronalni reformat otvoren, ako postoji.
- Trajanje simptoma i anamneza pada.
- Prethodna pretraga.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u starijeg bolesnika koji je došao zbog konfuzije brazde su na [strana] konveksitetu izbrisane; sumnjam na izodenzni subduralni hematom, ali nisam siguran/sigurna. Molim Vas da pogledate snimke; ako treba, razgovarajmo o preporuci dodatne pretrage.»*

Situacija 05 NEURO

Znakovi hernijacije ili akutnog hidrocefalusa

NEKA BUDE SPREMNO

- Presjeci na kojima se vide supraselarna cisterna, perimezencefalične cisterne i razina tonzila.
- Mjerenje pomaka središnje linije.
- Veličina ventrikula i usporedba s prethodnom pretragom.
- Uzrok: krvarenje, tvorba, infarkt, shunt.
- Stanje svijesti bolesnika i gdje se nalazi.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u bolesnika s odjela [odjel] vidim znakove [subfalcine / unkalne] hernijacije zbog [uzrok] i [hidrocefalus]. Prenio/la sam kliničaru; Htio/htjela bih odmah zajedno s Vama procijeniti snimke.»*

Situacija 06

NEURO · KRALJEŽNICA

Uputnica za MR zbog sumnje na kompresiju kralježnične moždine ili sindrom kaude ekvine

NEKA BUDE SPREMNO

- Klinički podaci s uputnice: deficit, razina, funkcija mokrenja i stolice, anamneza maligne bolesti ili infekcije.
- Je li sigurnosni upitnik za MR potpun (implantat, elektrostimulator srca).
- Prethodne slikovne pretrage kralježnice, ako postoje.
- Ako je očitano: sagitalni T2 i T1, označena razina kompresije, aksijalni presjeci spremni.
- Vaše pitanje o tome je li potrebna serija s kontrastom.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, za bolesnika koji dolazi s [klinička slika] zatražen je hitni MR zbog sumnje na kompresiju kralježnične moždine. Htio/htjela bih Vaše odobrenje protokola za [regija / cijela kralježnica] i seriju s kontrastom.» Nakon očitavanja: «Na razini [razina] vidim kompresiju moždine zbog [uzrok].»*

POGLAVLJE 2

Stanja prsnog koša i krvnih žila

Situacije 7–10 · Embolija, aorta, pneumotoraks, cijevi.

Situacija 07

PRSNI KOŠ

Plućna embolija i opterećenje desnog srca

NEKA BUDE SPREMNO

- CT plućna angiografija; medijastinalni prozor, označeno najproksimalnije mjesto embolije.
- Procijenjena je kvaliteta kontrasta.
- Omjer desnog i lijevog ventrikula, septum, refluks kontrasta.
- Vitalni znakovi bolesnika, potreba za kisikom.
- Dodatni nalazi u plućnom prozoru.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT plućnoj angiografiji bolesnika s odjela [odjel] vidim plućnu emboliju [razina] i znakove opterećenja desnog srca. Prijavio/la sam kliničaru. Htio/htjela bih zajedno s Vama potvrditi znakove opterećenja.»*

Situacija 08

KRVNE ŽILE

Akutni aortni sindrom

NEKA BUDE SPREMNO

- Nativna serija i arterijska faza; sagitalni kosi i koronalni reformati.
- Mjesto početka i kraja disekcijske membrane (flapa), zahvaćenost uzlazne aorte.
- Iz kojeg se lumena opskrbljuju ogranci.
- Perikardijalna tekućina, medijastinalni hematom, perfuzija organa.
- Krvni tlak, pulsevi, neurološka slika.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT aortografiji bolesnika iz hitne službe s boli u prsima vidim disekciju aorte; zahvaćenost uzlazne aorte [postoji/ne postoji]. Prijavio/la sam kliničaru. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti proširenost i ogranke.»*

Situacija 09

PRSNI KOŠ

Pneumotoraks i sumnja na tenzijski pneumotoraks

NEKA BUDE SPREMNO

- RTG ili CT; uvećano područje u kojem se vidi pleuralna linija.
- Pomak medijastinuma, položaj ošita.
- Je li bolesnik na respiratoru, ima li torakalni dren, je li stanje nakon zahvata?
- Prethodna rendgenska snimka.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na snimci bolesnika s odjela [odjel] vidim pneumotoraks [strana] i pomak medijastinuma na suprotnu stranu. Odmah sam nazvao/la kliničara. Molim Vas da pogledate snimku.»*

Situacija 10

PRSNI KOŠ

Malpozicionirana cijev ili kateter

NEKA BUDE SPREMNO

- Snimka koja prikazuje cijeli tijek uređaja; mjesto vrha uvećano.
- Vrsta uređaja i vrijeme postavljanja.
- Usporedba s prethodnom snimkom.
- Pneumotoraks da/ne.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na kontrolnoj snimci bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja nazogastrična sonda vidi se [u bronhalnom stablu / na neočekivanom mjestu]. Prenio/la sam kliničaru i preporučio/la ponovnu procjenu prije upotrebe sonde. Molim Vas da odobrite opis.»*

POGLAVLJE 3

Stanja abdomena i zdjelice

Situacije 11–17 · Slobodni zrak, ishemija, AAA, opstrukcija, krvarenje, torzija, ektopična trudnoća.

Situacija 11

ABDOMEN

Slobodni zrak

NEKA BUDE SPREMNO

- Cijeli abdomen u plućnom prozoru; označen presjek s najviše zraka.
- Mogući izvor: defekt stijenke, zadebljanje, zamućenje masnog tkiva.
- Je li nedavno učinjena operacija ili zahvat (radi razlikovanja postoperativnog zraka).
- Slobodna tekućina, kolekcija.
- Klinika: vrućica, defans, laboratorij.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u bolesnika s akutnim abdomenom vidim slobodni zrak [mjesto]; kao izvor mislim na [segment]. Nedavna operacija u anamnezi [ne postoji/postoji]. Prijavio/la sam kliničaru; Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti izvor.»*

Situacija 12

ABDOMEN

Sumnja na mezenterijsku ishemiju

NEKA BUDE SPREMNO

- Arterijska i portalna venska faza; sagitalni reformat duž SMA i SMV.
- Označeni crijevni segmenti bez postkontrastnog pojačanja ili s edemom.
- Pneumatoza i plin u portalnoj veni (plućni prozor).
- Poremećaj ritma, laktat i drugi relevantni laboratorijski nalazi.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT angiografiji starijeg bolesnika s jakom boli u trbuhu vidim defekt punjenja u SMA [razina] i gubitak postkontrastnog pojačanja [segment]. Mislim na mezenterijsku ishemiju, prijavio/la sam kliničaru. Molim Vas da odmah pogledate.»*

Situacija 13

KRVNE ŽILE

Rupturirana ili simptomatska AAA

NEKA BUDE SPREMNO

- Mjerenje najvećeg promjera (od vanjske do vanjske stijenke), proširenost.
- Snimke retroperitonealnog hematoma i ekstravazacije.
- Odnos s renalnim i ilijačnim arterijama.
- Krvni tlak, hemoglobin; postoji li poznata aneurizma na prethodnoj pretrazi?

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u bolesnika koji je došao s boli u leđima i hipotenzijom vidim aneurizmu abdominalne aorte i retroperitonealni hematom; mislim na rupturu. Prijavio/la sam kliničaru. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti mjerenja i ekstravazaciju.»*

Situacija 14

ABDOMEN

Opstrukcija zatvorene vijuge ili sumnja na strangulaciju

NEKA BUDE SPREMNO

- Označeno mjesto prijelaza (ili dva mjesta prijelaza); koronalni reformat otvoren.
- Vrtlog, edem, tekućina u mezenteriju.
- Pojačanje stijenke kontrastom: usporedba zahvaćene crijevne vijuge s normalnom vijugom.
- Prethodne operacije, anamneza kile.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u bolesnika s kliničkom slikom ileusa vidim [mjesto] izgled koji upućuje na zatvorenu vijugu i smanjeno pojačanje stijenke. Sumnjam na strangulaciju. Molim Vas da pogledate snimke.»*

Situacija 15

ABDOMEN · KRVNE ŽILE

Aktivno gastrointestinalno krvarenje: CT angiografija

NEKA BUDE SPREMNO

- Nativna, arterijska i portalna venska faza jedna uz drugu; ista razina presjeka sinkronizirana.
- Presjeci na kojima se ekstravazacija vidi u arterijskoj fazi i povećava u venskoj fazi.
- Moguća krvna žila koja opskrbljuje.
- Hemoglobin, transfuzija, nalaz endoskopije.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT angiografiji bolesnika s krvarenjem iz probavnog sustava vidim u [segment] aktivnu ekstravazaciju koja se pojavljuje u arterijskoj fazi i povećava u venskoj fazi. Možda će biti potrebno intervencijsko liječenje; Htio/htjela bih to procijeniti zajedno s Vama.»*

Situacija 16

SKROTUM · ZDJELICA

Sumnja na torziju testisa ili jajnika

NEKA BUDE SPREMNO

- Usporedni zapisi obiju strana s istim postavkama doplera.
- Veličina, ehogenost, snimka znaka vrtloga.
- Vrijeme početka boli.
- Za jajnik: rezultat testa na trudnoću, poznata cista ili tvorba.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, u bolesnika s naglom boli koja je počela prije [trajanje] dopler UZV [testisa / jajnika] pokazuje [strana] izrazito smanjen protok i znak vrtloga. Mislim na torziju, prijavio/la sam kliničaru. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti snimke.»*

Situacija 17

TRUDNOĆA

Ektopična trudnoća i hemoperitoneum

NEKA BUDE SPREMNO

- Snimke maternice (gestacijska vreća da/ne), adneksa i Douglasova prostora.
- Snimka Morisonova džepa.
- Test na trudnoću i relevantni laboratorijski nalazi, datum posljednje menstruacije.
- Hemodinamsko stanje bolesnika.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na UZV-u bolesnice s pozitivnim testom na trudnoću i boli u zdjelici nisam vidio/la gestacijsku vreću u maternici; u [strana] adneksu postoji tvorba i ehogena slobodna tekućina. Prijavio/la sam kliničaru i ginekologu. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti snimke.»*

POGLAVLJE 4

Trauma i stanja kralježnice

Situacije 18–21 · CT cijelog tijela, vratna kralježnica, parenhimski organi, zdjelica.

Situacija 18

TRAUMA

CT cijelog tijela: prvo očitavanje i preliminarna prijava

NEKA BUDE SPREMNO

- Popis životno ugrožavajućih nalaza (intrakranijalno krvarenje, pneumotoraks, aorta, aktivno krvarenje).
- Označen presjek na kojem se svaki nalaz najbolje vidi.
- Mehanizam ozljede, hemodinamika, učinjeni zahvati.
- Popis regija koje još niste pregledali.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, u bolesnika kojem je nakon prometne nesreće učinjen CT cijelog tijela pri prvom očitavanju vidim [nalaz 1] i [nalaz 2]. Traumatološkom timu dao/la sam preliminarnu prijavu. Nastavljam s detaljnim očitavanjem; Htio/htjela bih zajedno s Vama potvrditi prioritetne nalaze.»*

Situacija 19

TRAUMA · KRALJEŽNICA

Prijelom ili poremećaj poravnanja vratne kralježnice

NEKA BUDE SPREMNO

- Sagitalni i koronalni reformati; koštani prozor.
- Razina prijeloma, poravnanje fasetnih zglobova, kanal.
- Je li zahvaćen transverzalni foramen?
- Nalazi neurološkog pregleda.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u vratne kralježnice bolesnika s traumom i ovratnikom vidim [prijelom / iščašenje fasetnog zgloba] na razini [razina]; transverzalni foramen [je zahvaćen / nije zahvaćen]. Kliničaru sam prenio/la da ovratnik ostane. Htio/htjela bih razgovarati o potrebi za MR-om i CTA.»*

Situacija 20

TRAUMA · ABDOMEN

Aktivna ekstravazacija kod ozljede parenhimskog organa

NEKA BUDE SPREMNO

- Arterijska i portalna venska faza jedna uz drugu.
- Proširenost laceracije i zahvaćenost hilusa.
- Količina hemoperitoneuma i mjesto najgušćeg ugruška.
- Hemodinamika i podaci o transfuziji.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, na CT-u bolesnika s tupom traumom vidim laceraciju [organ] i aktivnu arterijsku ekstravazaciju; hemoperitoneum [malen/umjeren/opsežan]. Prijavio/la sam traumatološkom timu. Htio/htjela bih zajedno s Vama procijeniti mogućnost intervencijskog liječenja.»*

Situacija 21

TRAUMA · ZDJELICA

Prijelom zdjelice i zdjelično krvarenje

NEKA BUDE SPREMNO

- Prijelomi prednjeg i stražnjeg prstena, sakroilijakalni zglobovi, simfiza.
- Snimke zdjeličnog hematoma i ekstravazacije.
- Nalazi vezani uz mokraćni mjehur i uretru.
- Je li postavljen zdjelični pojas, hemodinamika.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, u bolesnika s traumom i zdjeličnim pojasom vidim [prijelomi] i aktivnu ekstravazaciju unutar zdjeličnog hematoma. Prijavio/la sam traumatološkom timu. Molim Vas da odmah procijenite potrebu za intervencijskom radiologijom.»*

POGLAVLJE 5

Situacije vezane uz sigurnost, protokol i opis

Situacije 22–25 · Reakcija na kontrast, sigurnost MR-a, prikladnost uputnice, ispravak opisa.

Situacija 22

SIGURNOST

Reakcija na kontrast

NEKA BUDE SPREMNO

- Najprije ostanite uz bolesnika i pozovite hitni tim Vaše ustanove prema protokolu; nazovite tek nakon toga.
- Vrsta kontrastnog sredstva i vrijeme primjene.
- Simptomi i vrijeme početka, vitalni znakovi.
- Prethodno poznata alergija u anamnezi.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, u bolesnika koji je tijekom [pretraga] primio jodno kontrastno sredstvo razvili su se [simptomi]. Prekinuli smo injekciju, pozvali hitni tim, bolesnik je trenutačno [stanje]. Javljam Vam radi informacije; molim Vas da dođete / da me uputite.»*

Situacija 23

SIGURNOST

Pitanje o implantatu ili metalu prije MR-a

NEKA BUDE SPREMNO

- Ispunjeni sigurnosni upitnik za MR.
- Vrsta implantata, datum ugradnje, kartica ili dokumentacija uređaja, ako postoji.
- Prethodna snimka ili CT koji prikazuje implantat, ako postoji.
- Hitnost pretrage i mogućnost alternativne pretrage.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, bolesnik za kojeg je zatražen hitni MR ima [implantat]; potvrda o MR kompatibilnosti [postoji/ne postoji]. Bolesnika nisam uveo/la u prostoriju. Htio/htjela bih s Vama odlučiti može li se pretraga učiniti i o alternativi.»*

Situacija 24

PROTOKOL

Uputnica i kliničko pitanje se ne podudaraju ili je protokol nejasan

NEKA BUDE SPREMNO

- Uputnica i dodatni klinički podaci koje ste dobili od kliničara.
- Zatražena pretraga, alternativa koju predlažete i obrazloženje.
- Podaci potrebni za kontrast (bubrežna funkcija, alergija, trudnoća).
- Popis protokola ustanove.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, iz hitne službe zatražena je [pretraga] zbog [kliničko pitanje]. Prema kliničkim podacima mislim da bi [alternativa] mogla biti prikladnija jer [obrazloženje]. Htio/htjela bih s Vama potvrditi odluku o protokolu.»*

Situacija 25

OPIS

Važan nalaz propušten u prethodnom opisu ili preliminarnom očitanju

NEKA BUDE SPREMNO

- Relevantni opis ili preliminarno očitanje i vrijeme slanja.
- Označena snimka propuštenog nalaza.
- Trenutačno stanje bolesnika i gdje se nalazi.
- Nacrt rečenice za ispravljeni opis.

UVODNA REČENICA

> *«Doktore, ponovnim pregledom [pretraga] za koju sam u [vrijeme] dao/la preliminarno očitanje uočio/la sam [nalaz]. Može biti klinički važno. Prije nego što prijavim kliničaru, Htio/htjela bih to potvrditi s Vama i dobiti uputu za dodatak opisu.»*

ZAVRŠETAK

Nakon poziva

Ako se ishod razgovora ne zapiše, izgubit će se.

Nakon što spustite slušalicu

- [ ] Preporuku i odluku mentora ponovio/la sam svojim riječima i potvrdio/la.
- [ ] Prijavio/la sam nalaz kliničaru; zabilježio/la sam kome i u koliko sati.
- [ ] Opis sam dovršio/la ili ispravio/la prema uputama mentora.
- [ ] Ako je preporučena dodatna pretraga, prenio/la sam to timu koji je zatražio pretragu.
- [ ] Ono što sam naučio/la nakon dežurstva zapisao/la sam u svoju bilježnicu pogrešaka.

Završna rečenica

«Doktore, koliko sam razumio/la, [odluka]. Kliničaru to prenosim kao [poruka] i prema tome pišem opis. Želite li još nešto dodati?»

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Spremni ste za poziv. Sada se usredotočite na to da ne propustite nalaz koji zahtijeva poziv.

«40 najčešće propuštenih nalaza na dežurstvu» (Bonus 2): otvorite datoteku i pogledajte gdje se skrivaju najčešće propušteni nalazi i u kojem se prozoru otkrivaju.